

6 - 06- Les Angines Aiguës - Pr. Raji

Bonjour, je suis professeur Raji, otorhinolaryngologiste. J'ai le plaisir aujourd'hui, dans le cadre des cours de 5e année des études médicales, sous module de pathologie ORL, de vous parler d'un chapitre en relation avec les angines aiguës. Les objectifs pédagogiques de ce cours-là vont concerner un certain nombre d'éléments, dont plus particulièrement définir une angine aiguë, différencier sur le plan clinique une angine érythémateuse d'une angine érythématopultacée d'une angine vésiculeuse et d'une angine ulcéreuse aux pseudomembraneuses, préciser le bilan clinique et paraclinique permettant d'orienter le diagnostic vers une étiologie virale ou streptococcique devant une angine érythémateuse ou érythématopultacée, préciser la prise en charge des complications loco-régionales des angines aiguës, savoir traiter une angine aiguë érythémateuse ou érythématopultacée d'origine streptococcique, préciser les indications de l'amygdalectomie, savoir orienter le diagnostic étiologique d'une angine vésiculeuse, et savoir différencier une angine ulcéreuse d'une éventualité d'un cancer de l'amygdale, qui peut être un des diagnostics différentiels qu'il ne faut pas omettre devant une angine ulcéreuse, et dans un dernier lieu savoir rechercher les signes en faveur d'une mononucléose infectieuse devant une angine pseudomembraneuse, et savoir traiter une angine mononucléotique.

Alors c'est quoi une angine aiguë ? C'est une inflammation aiguë de l'oropharynx, plus ou moins focalisée sur les amygdales palatines. C'est une pathologie assez fréquente chez l'enfant, et un germe responsable de cette pathologie qui reste un germe très redoutable, non pas parce qu'il a développé des résistances, mais parce qu'il peut être responsable de complications. C'est le streptocoque A bêta-hémolytique.

C'est une pathologie qui est une pathologie de traitement médical, et que, bien entendu, il faut connaître pour pouvoir la prendre en charge. L'angine aiguë, c'est une inflammation, comme vous voyez sur cette photo-là, des amygdales de l'oropharynx et des amygdales palatines. En guise de rappel anatomique, l'amygdale palatine est une partie de l'anneau de Val d'Eyer, qui siège au niveau de la loge amygdalienne, limitée en avant par le pilier antérieur du voile du palais, et le pilier postérieur délimitant la loge amygdalienne, à l'intérieur de laquelle on va retrouver l'amygdale palatine.

Cette amygdale palatine peut être le siège d'infection, plus particulièrement dans ce cadre-là au streptocoque A d'état hémolytique, et, bien sûr, être à l'origine d'une angine. Sur le plan épidémiologique, les angines aiguës représentent une pathologie de fréquence très élevée, touchant plus particulièrement l'enfant, sans aucune prédominance sexuelle. Sur le plan étiologique, elles peuvent être secondaires à une atteinte virale, telles que les adénovirus, les virus influenzés et para-influenzés, le virus respiratoire syncytial, le cytomegalovirus, le virus d'Ebstein-Barr et l'herpex simplex virus ou l'enterovirus Koksaki.

Les étiologies bactériennes sont prédominées par le streptocoque A d'état hémolytique, mais on peut rencontrer le *Fusobacterium*, le *Tropheryma Vincenti*, l'*Hémophilus*, le *Pneumococque*, le

Staphylococque, le Chlamydiae, le Mycoplasme et les Chlamydiae de façon très exceptionnelle actuellement. Sur le plan clinique, nous allons différencier, en fonction de l'aspect que peut prendre l'angine aiguë, différentes entités, à savoir les angines aiguës érythémateuses et érythématopultacées, les angines vésiculeuses, les angines ulcéreuses et les angines pseudomembraneuses. Nous allons étudier une par une ces entités et préciser quelles seraient les étiologies éventuelles et leurs prises en charge.

Concernant les angines érythémateuses et érythématopultacées, les signes fonctionnels pour lesquels le patient viendra consulter, ou l'enfant amené par ses parents, est amené pour des douleurs pharyngées accentuées à la déglutition. C'est en fait une déglutition douloureuse, avec parfois une extension de la douleur aux oreilles responsable d'une otalgie réflexe. Le patient vous décrit une fièvre, qui peut être variable de 38 à 39 degrés, avec frissons, asthénie et parfois dénoncées.

C'est en fait une symptomatologie fonctionnelle, qui est centrée sur une dysphagie fébrile. L'examen de l'oropharynx, dans ce cadre-là, va retrouver, à l'aide d'une source de lumière et d'un abaisse-langue, des amygdales palatines rouges augmentées de volume, avec ou sans un enduit blanchâtre décollable. Ce qui fait différencier une angine érythémateuse, comme vous voyez sur cette photo-là, d'une angine érythématopultacée.

Cette amygdale palatine rouge peut être associée à une inflammation diffuse de l'oropharynx, comme vous voyez sur cette photo-là du haut, et souvent on a une atteinte bilatérale. Parfois, il peut s'associer à ces amygdales inflammées, un aspect pétéchial au niveau du voile du palais, et qui pourrait éventuellement évoquer des étiologies particulières. La palpation des ganglions retrouvera des adénopathies fermes et sensibles de sièges, le plus souvent sous-digastriques.

Et, à l'examen général, on doit s'acharner à rechercher une splénomégalie qui pourrait orienter vers une des étiologies des angines érythémato- érythématopultacées. Et bien sûr, dans ce cadre-là, ne pas oublier de rechercher d'emblée les complications qui peuvent survenir à un stade de début. Sur le plan paraclinique, le prélèvement de gorge est rarement effectué en pratique courante, et la numération formule sanguine peut retrouver une hyperleucocytose, si bien sûr elle est réalisée, et qui va orienter plutôt vers une étiologie bactérienne.

L'élément le plus important sur le plan du diagnostic est le test de diagnostic rapide qui va permettre la mise en évidence de l'antigène spécifique du streptocoque A-bêta-hémolytique par coloration visuelle. Ce test de diagnostic rapide a une spécificité de 95% et une sensibilité de 80 à 90%. Ce test de diagnostic rapide est de réalisation relativement simple, comme nous allons le voir par la suite.

Ce test de diagnostic rapide va utiliser un icoviant qui va assurer le prélèvement au niveau de l'amygdale palatine, et après avoir trempé cet icoviant pendant une minute dans une solution

utilisant des réactifs donnés dans le boîtier du test de diagnostic rapide, on pourra mettre une bandelette réactive en contact du mélange pour permettre de rechercher l'existence d'antigènes du streptocoque bêta-hémolytique dans le mélange. Dans cette situation-là, la réaction visualisée sur la bandelette réactive va nous permettre de conclure un résultat positif, un résultat négatif ou un résultat invalide. Elle va donc nous permettre de rattacher l'angine que nous avons à une angine streptocoque lorsque le résultat est positif, à une angine d'origine virale lorsqu'il est négatif ou bien sûr, dans le cadre du résultat invalide, de ne pas permettre de prendre de décision.

L'évolution des angines érythémateuses ou érythématopultacées est souvent favorable, mais parfois on peut avoir des complications qui peuvent apparaître de façon immédiate sous forme d'un flègement périamygdalien ou sous forme d'abcès rétrofaringé. Le plus fréquent, c'est le flègement périamygdalien qui va se manifester sous la forme d'une collection purulente qui siège entre la mygdale palatine et la paroi musculaire du pharynx, réalisant un tableau clinique d'angine avec une altération importante de l'état général et un syndrome fébrile important. Dans ce cadre, on va trouver une triade symptomatique qui va associer un trismus, c'est-à-dire une difficulté d'ouverture buccale, à un œdème de la luette et une vossure du pilier antérieur de la mygdale comme vous voyez sur ce schéma-là, sur cette photo-là.

L'abcès rétrofaringé peut se voir dans les situations d'angines pédiatriques, surtout chez des petits-enfants avec une vossure de la paroi postérieure de l'oropharynx. D'autres complications peuvent se voir de façon secondaire et relativement tardive et qui sont largement représentées par le rhumatisme articulaire aigu et l'agglomération du frot aigu. Alors, quel est le traitement de l'angine érythémateuse et érythématopultacée ? Ce qu'il faut savoir, c'est que toute angine érythémateuse ou érythématopultacée, en dehors de la possibilité de pouvoir faire le test de diagnostic rapide, va être considérée comme angine streptococcique, jusqu'à preuve du contraire.

Et donc, sa thérapeutique va se baser sur l'usage d'une pénicillinothérapie par voie orale pendant une durée de 10 jours ou une amoxicilline pendant 6 jours. Ce qui est recommandé actuellement, c'est l'usage d'une thérapeutique par antibiothérapie pendant une courte durée pour favoriser l'observance thérapeutique. Lorsque les patients présentent une allergie à la pénicilline, on pourra faire appel au macrolide.

Et dans tous les cas, bien sûr, un traitement symptomatique peut être préconisé à base d'antalgiques antipyrétiques. Il n'y a pas de place aux anti-inflammatoires ni aux traitements locaux. Le traitement spécifique du flègement pyrhamigdalien, réalisant une prise en charge urgente, en hospitalisation, va nécessiter l'incision drainage de l'abcès.

Vous voyez sur cette photo comment est réalisée la ponction du flègement pyrhamigdalien et l'incision du pilier antérieur avec évacuation de sécrétion et réalisation d'un prélèvement bactériologique et qui va permettre la disparition de la vossure. Mais le traitement doit reposer

sur une antibiothérapie parentérale probabiliste au début qui pourrait éventuellement être orientée par le prélèvement bactériologique. Mais souvent, c'est une antibiothérapie visant le germe streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et dans tous les cas, du moment que l'angine s'est compliquée, il faut prévoir une amygdalectomie après rétablissement et disparition de l'inflammation loco-régionale.

Les indications de l'amygdalectomie sont représentées par l'angine aiguë à répétition, par les amygdales obstructives comme vous voyez sur cette photo-là où les deux amygdales hypertrophiées viennent l'une au contact de l'autre responsables d'un syndrome d'apnée de sommeil. Troisième indication, c'est les amygdalites chroniques récurrentes où les cryptes au niveau des amygdales palatines vont être et vont entretenir des sécrétions caseuses. La quatrième indication, c'est l'amygdalectomie qui va faire suite au fléguement pyrhéamydalien bien sûr après rétablissement, après traitement médical.

Et, chose qui pourrait éventuellement être discutée en termes d'indications d'amygdalectomie, ce sont les complications générales telles que le rhumatisme articulaire aigu ou la glomérulonephrite aiguë, surtout lorsque celles-ci sont associées à des angines à répétition. Qu'en est-il maintenant des angines vésiculeuses ? Alors, les angines vésiculeuses vont se manifester sur le plan clinique de façon similaire à l'angine érythémateuse et érythématopultacée. La seule différence, c'est que sur le plan des signes physiques, on va retrouver un oropharynx rouge parsemé de vésicules de petite taille, comme vous voyez sur cette photo-là, avec au niveau du voile, de l'aluète et des piliers, souvent bilatéral, associé à une gingivite ou une gingivostomatite.

Le germe le plus fréquemment incriminé dans le cadre des angines vésiculeuses est le herpès simplex virus. Lorsque l'angine vésiculeuse est unilatérale, on pensera à la possibilité d'un zona et bien entendu, il ne faut pas oublier l'étiologie de la maladie main-pied-bouche, secondaire aux entérovirus Coxsackie et qui peut être associée des lésions vésiculeuses de l'oropharynx et donc une angine vésiculeuse avec des lésions touchant le pied, la main et la main. Alors, quel est bien sûr le traitement de ces angines vésiculeuses ? C'est des infections virales.

Ils répondent essentiellement à un traitement symptomatique antalgique local et général. L'indication d'usage des antiviraux est discutée au cas par cas. Les angines ulcéreuses.

Les angines ulcéreuses sont représentées par deux grandes entités, à savoir l'angine de Vincent et le chancre céphilitique. L'angine de Vincent est une infection secondaire à un bassigrame négatif, ce qu'on appelle le *Physiobacterium* et une spiroquette qu'on appelle le *Tréponema Vincentii*. C'est une pathologie qui va toucher plus particulièrement l'adulte jeune ou l'adolescent avec un mauvais état bucodentaire.

La symptomatologie fonctionnelle se résume en une douleur pharyngée peu intense et unilatérale, mais par contre une asthénie importante et une fièvre inférieure à 38 degrés. L'examen chez ce patient-là va retrouver une ulcération au niveau de l'amygdale palatine.

L'ulcération au niveau de l'amygdale palatine est souvent unilatérale et irrégulière et quand on s'intéresse à sa description sémiologique, il est recouvert par des fausses membranes facilement détachables, ce qui la différencie de la diphthérie.

En plus, ces fausses membranes ne dépassent pas l'amygdale vers les régions avoisinantes. Quand on touche, on palpe l'amygdale, il n'y a pas d'induration au toucher et l'examen cervical va retrouver de petites adénopathies cervicales et unilatérales. Sur le plan paraclinique, le diagnostic de l'angine de Vincent se fait sur une analyse bactériologique d'un prélèvement de gorge permettant de mettre en évidence une association fusospirillaire et dans ce cadre-là, la numération formule sanguine reste tout à fait normale.

L'angine de Vincent est une angine très grande pourvoyeuse de complications, c'est la raison pour laquelle il faut la connaître. Cela peut être des complications de type abcès, des espaces profonds cervicofaciaux, des cellulites cervicales, voire même une thrombose de la veine jugulaire interne. Quelle est la thérapeutique de cette angine de Vincent ? C'est une antibiothérapie qui pourrait faire appel à l'usage d'un métronidazole pendant une dizaine de jours.

Et bien sûr, pour ne pas avoir de récurrence, il faut traiter les caries dentaires après guérison. La deuxième entité dans le cadre des angines ulcéreuses est représentée par le chancre céphalique. Celui-ci va avoir un tableau clinique similaire à l'angine de Vincent.

La seule différence, c'est que le chancre est un chancre dur sur sa base, sur une amygdale qui reste relativement souple. Les adénopathies cervicales, à la différence de l'angine de Vincent, qui sont de petite taille, ici sont représentées par de grosses adénopathies cervicales. Comme pour toute syphilis, le diagnostic sera retenu soit après prélèvement et étude bactériologique recherchant le *tréponème pallidum* ou après sérologie céphalique.

Dans tous les cas, il faut réaliser systématiquement une sérologie VIH à la recherche d'une infection rétrovirale. Alors, quel est le traitement du chancre céphalique au niveau de l'amygdale, de l'angine céphalique ulcéreuse ? C'est le traitement de la syphilis primaire qui pourra faire appel à une injection d'extensiline ou d'initiation d'inothérapie pendant une dizaine de jours. Les angines ulcéreuses portent sur le plan pratique le problème du diagnostic différentiel avec un certain nombre d'entités pathologiques représentées essentiellement par les localisations farangées des hémopathies, par le cancer de l'amygdale et par l'aft amygdalien.

Qu'en est-il maintenant des angines pseudomembraneuses ? Les angines pseudomembraneuses représentent l'angine diphtérique et la mononucléose infectieuse. La première entité dans le cadre des angines pseudomembraneuses est représentée par l'angine diphtérique. C'est une pathologie qui a une période d'incubation d'à peu près 4 jours qui commence de façon insidieuse réalisant une discrète altération de l'état général au début avec une fièvre modérée et une dysphagie modérée.

C'est une angine qui a été recouverte par des enfants qui n'ont pas reçu de vaccination anti-

diphthérique. C'est actuellement une situation très exceptionnelle. Sur le plan symptomatologie physique, l'examen de l'oropharynx va trouver un oropharynx rouge de façon diffuse, c'est-à-dire une angine rouge recouverte d'un enduit blanchâtre épais brillant adhérent à la muqueuse.

entraîner insainement ce qu'on appelle les fausses membranes. Les adénopathies cervicales soudigastriques sont volumineuses et sensibles. Quand l'angine diphthérique n'est pas prise en charge, ces fausses membranes vont s'étendre, plus particulièrement au niveau du larynx et des branches, réalisant un syndrome malin.

Heureusement que c'est une pathologie qu'on ne voit presque plus actuellement. La prise en charge de l'angine diphthérique nécessite une hospitalisation, une mise en quarantaine et une déclaration obligatoire. Un prélèvement de gorge doit être fait de façon systématique pour affirmer le diagnostic.

Un test de mononucléose infectieuse, le MNITest, doit être aussi réalisé pour distinguer entre angine diphthérique et angine mononucléosique. On peut s'aider du résultat de l'annumération formule sanguine qui montre dans le cadre de l'angine mononucléosique une prédominance des basophiles. Le traitement repose en urgence sur une sérothérapie et sur une antibiotérapie basée essentiellement sur l'usage des pénicillines ou des macrolides en cas d'allergie.

La réanimation d'un patient atteint d'une angine diphthérique sera en fonction de l'état général du patient. La deuxième étiologie, et ça c'est une étiologie relativement fréquente concernant les angines pseudomembraneuses, c'est la mononucléose infectieuse. Cette mononucléose infectieuse est connue par son polymorphisme clinique et peut se manifester sous plusieurs aspects.

Il touche particulièrement l'adulte jeune, réalisant une angine avec des fausses membranes grisâtres et nécrotiques comme vous voyez sur cette photo avec des amygdales hypertrophiées rouges et un enduit blanchâtre grisâtre et nécrotique. Le patient présente en plus de cette angine une altération de l'état général et une fièvre très élevée et une asthénie importante. Des adénopathies pseudigastriques, des ratschcutanées et une splénomégalie.

Il faut bien sûr rechercher de façon systématique chez des patients qui ont des angines érythémateuses ou érythématopultacées faisant évoquer le diagnostic de la mononucléose infectieuse. Devant un tableau clinique fortement évocateur de mononucléose infectieuse, le diagnostic sera retenu sur un test de MNI test positif et évoqué devant une numération formule sanguine montrant une hyperleucocytose abasophie. Le traitement de la mononucléose infectieuse est un traitement symptomatique Ce qu'il faut savoir c'est que les bêtalactamines peuvent être responsables d'un exantème important et c'est la raison pour laquelle il faut éviter de les utiliser dans la mononucléose infectieuse.

En conclusion, les angines aiguës représentent une pathologie fréquente. Réalisant des tableaux

cliniques diversifiés comme nous l'avons vu, faisant distinguer l'angine érythémateuse de l'erythématopultacée, de l'angine vésiculeuse de l'ulcéreuse et de l'angine pseudomembraneuse, ce qu'il faut retenir essentiellement c'est que l'angine streptococcique est de loin l'angine la plus fréquente qu'il faut bien sûr bien savoir prendre en charge par un traitement adapté. Pourquoi un traitement adapté ? C'est pour bien sûr prévenir les complications éventuelles qui peuvent éventuellement s'y revenir au cours de cette pathologie très très fréquente.

Je vous remercie.